

ESCALA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

SRS-2

Segunda Edição

Dados do avaliado

NOME

Sophia Correa

SEXO

Feminino

IDADE

11 anos

ESCOLARIDADE

Ensino fundamental

PROFISSIONAL

**Dra. Jacqueline O. Caires -
CRP09/6017**

TABELA NORMATIVA

Idade Escolar

Finalidade do relatório

Este relatório apresenta os resultados do SRS-2 em formato gráfico, tabular e interpretativo, com foco na compreensão dimensional da responsividade social. Os resultados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos aplicados.

Visão geral

Descrição do instrumento

A Escala de Responsividade Social – Segunda Edição (SRS-2) é um instrumento padronizado de rastreio destinado à mensuração de dificuldades relacionadas à responsividade social, comunicação social recíproca e padrões restritos e repetitivos. O resultado não deve ser utilizado de forma isolada para conclusão diagnóstica.

● **T ≤ 59** Dentro dos limites normais

● **60-65** Nível leve

● **66-75** Nível moderado

● **≥ 76** Nível severo

ESCORE TOTAL

Nível moderado

T 68

MAIOR ESCORE

Comunicação Social

T 70

MÉDIA NORMATIVA

Referência central

T 50

Perfil dos Escores T

Distribuição dos escores T por dimensão, com média normativa em T=50 e marcação visual das faixas referenciais.

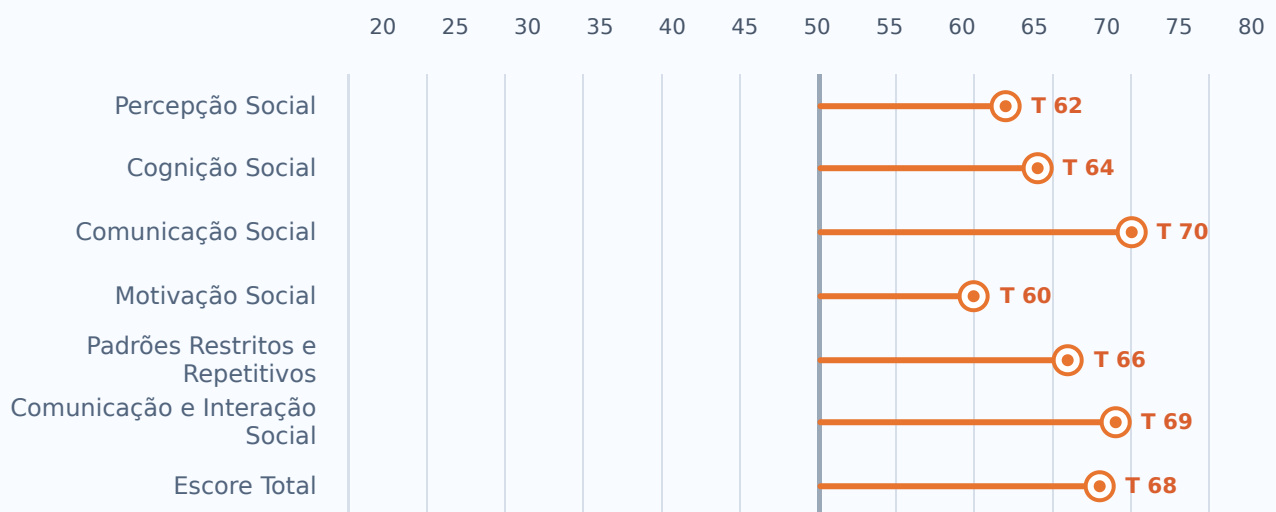


Tabela de escores

Escala	Pontuação bruta	Escore T	Classificação
Percepção Social	12	62	Nível leve
Cognição Social	15	64	Nível leve
Comunicação Social	33	70	Nível moderado
Motivação Social	16	60	Nível leve
Padrões Restritos e Repetitivos	18	66	Nível moderado
Comunicação e Interação Social	76	69	Nível moderado
Escore Total	94	68	Nível moderado

A tabela apresenta pontuação bruta, Escore T e classificação clínica. Escores mais elevados indicam maior frequência ou intensidade de dificuldades associadas à responsividade social.

Mapa dos domínios

62

Percepção Social

PB 12 · IC 58-66 · Nível leve

64

Cognição Social

PB 15 · IC 60-68 · Nível leve

70

Comunicação Social

PB 33 · IC 66-74 · Nível moderado

60

Motivação Social

PB 16 · IC 56-64 · Nível leve

66

Padrões Restritos e Repetitivos

PB 18 · IC 62-70 · Nível moderado

69

Comunicação e Interação Social

PB 76 · IC 65-73 · Nível moderado

68

Escore Total

PB 94 · IC 64-72 · Nível moderado

LEITURA DA TABELA**Resultados normativos**

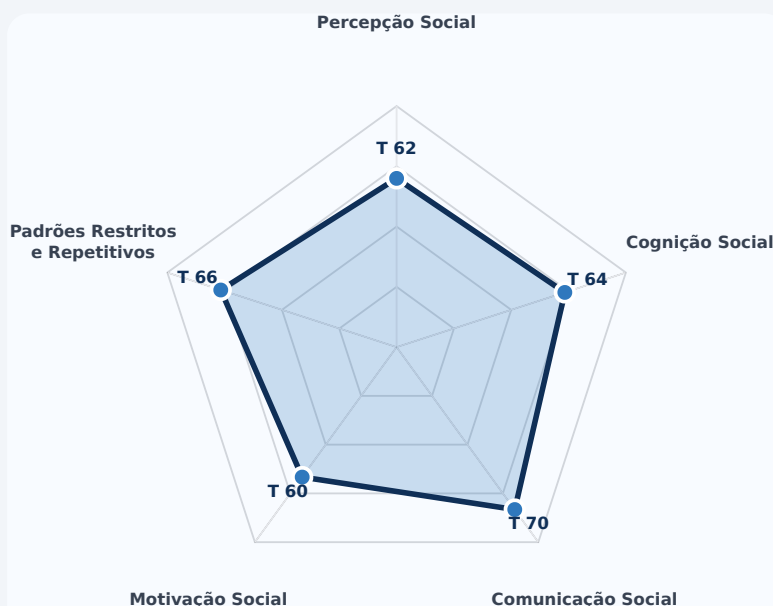
Em Sophia Correa, o Escore Total foi T=68, classificado em nível moderado. Domínios elevados: Percepção Social, Cognição Social, Comunicação Social, Motivação Social, Padrões Restritos e Repetitivos, Comunicação e Interação Social.

DESTAQUE CLÍNICO**Comunicação Social**

Maior elevação: Comunicação Social, T=70, nível moderado. Como o Escore Total está elevado, considerar padrão global e convergência clínica.

Radar clínico

Radar clínico dos domínios



Percepção Social **T 62**
Cognição Social **T 64**
Comunicação Social **T 70**
Motivação Social **T 60**
Padrões Restritos e Repetitivos **T 66**

Leitura do radar

O radar apresenta a distribuição dos escores T entre os principais domínios do SRS-2. No protocolo de Sophia Correa, o Escore Total foi T=68 e o domínio mais elevado foi Comunicação Social, com T=70.

O polígono sugere perfil global elevado em nível moderado, com maior expansão relativa no domínio Comunicação Social. Esse gráfico deve ser usado para verificar se o perfil é homogêneo ou se existem picos específicos entre comunicação/interação social e padrões restritos ou repetitivos.

Análise clínica

Síntese interpretativa

Interpretação clínica real do protocolo. Em análise clínica, os resultados obtidos por Sophia no SRS-2 indicam perfil global de responsividade social com elevação moderada.

CONCLUSÃO DO TESTE

Perfil global em nível moderado

O resultado geral do SRS-2 apresenta elevação clinicamente relevante, com Escore Total T=68.

PONTO DE ATENÇÃO

Comunicação Social

Maior elevação do perfil: T=70, classificada em nível moderado.

REGRA DE SEGURANÇA

Não fechar diagnóstico isolado

O SRS-2 é instrumento de rastreio e quantificação dimensional. A hipótese diagnóstica depende da integração com outros dados clínicos.

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

Investigar se houver convergência

A hipótese depende de anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e prejuízos funcionais.

Recomendações interpretativas

- Integrar os achados à anamnese e à observação clínica.
- Verificar impacto funcional em ambiente familiar, escolar e social.
- Investigar funcionamento adaptativo e histórico do desenvolvimento.
- Utilizar instrumentos complementares quando houver suspeita clínica de TEA.